Estrategias y prevención del consumo del vaper en estudiantes de grado noveno del gimnasio Santander

Dana Yissela López Pirabaguen

Colegio gimnasio santander

Tunja

2026

Introducción

El consumo de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), conocidos comúnmente como vapeadores o cigarrillos electrónicos, ha aumentado de manera significativa entre la población adolescente y juvenil, y se ha convertido en una preocupación creciente en los ámbitos familiar, educativo y sanitario. Estos dispositivos suelen percibirse, de forma errónea, como alternativas seguras al tabaco tradicional; su uso se ve favorecido por los diseños modernos, la variedad de sabores y la presión social, a pesar de la evidencia científica sobre sus efectos nocivos para la salud física (Popova, 2020).

Según Álvarez Orozco et al. (2026), los SEAN representan una amenaza emergente para la salud pública, pues su consumo libera sustancias químicas que afectan los sistemas respiratorio, cardiovascular y neurológico. En particular, la nicotina presente en la mayoría de estos dispositivos genera adicción y altera el desarrollo cerebral en edades tempranas, con efectos sobre la memoria, la atención y el control de impulsos, además de aumentar el riesgo de enfermedades a largo plazo. A esto se suma la falta de información veraz en los entornos educativos, donde incluso algunos docentes no cuentan con los conocimientos necesarios para abordar el tema, lo que facilita su difusión entre los estudiantes de grado noveno (Monge Ríos, 2025).

El presente proyecto de grado tiene como objetivo diseñar una estrategia educativa de prevención dirigida a los estudiantes de grado noveno del Gimnasio Santander, con el fin de concientizar sobre los riesgos del consumo del vapeador, fomentar hábitos saludables y promover la toma de decisiones informadas y responsables. Para lograrlo, se combinan un diagnóstico inicial mediante encuesta y actividades participativas (dinámicas grupales, charla informativa y encuesta final) basadas en evidencia científica, con el propósito de transformar las actitudes frente al consumo, fortalecer el autocuidado y contribuir a la reducción de esta problemática en la institución educativa.

Pregunta problema

¿Qué estrategia educativa permite prevenir el consumo de vapeadores en los estudiantes de grado noveno del Gimnasio Santander?

Resumen

La prevención del consumo de vapeadores es un tema relevante de salud pública, especialmente entre los adolescentes, quienes suelen subestimar los riesgos de la nicotina y de las sustancias químicas presentes en estos dispositivos. Este proyecto diseñó una estrategia educativa para prevenir su consumo en estudiantes de grado noveno del Gimnasio Santander (Tunja), a partir de los factores que favorecen el inicio del consumo: la influencia de los jóvenes, las redes sociales y la falta de información. Se empleó una metodología mixta con una encuesta diagnóstica (25 estudiantes), actividades participativas dinámicas grupales, charla informativa y semáforo de mitos y realidades y una encuesta final (25 estudiantes). En el diagnóstico, el 41,7 % consideraba el vapeo menos dañino que el cigarrillo y el 45,8 % no había recibido información en el colegio. En la encuesta final, el 100 % reportó haber recibido charlas, el 92 % sabe que genera adicción y el 92 % rechazaría una oferta de consumo, aunque el 36 % aún lo cree menos dañino. Se concluye que las estrategias participativas fortalecen el autocuidado, pero la creencia de menor daño debe seguir trabajándose.

Planteamiento del problema

El uso de cigarrillos electrónicos ha crecido de manera significativa en los últimos años, especialmente entre jóvenes y estudiantes, quienes lo perciben como una alternativa menos nociva que el tabaco convencional. La facilidad de acceso y la variedad de sabores aumentan su atractivo, lo que representa un reto importante para la salud pública (Becerra Benavides et al., 2022).

El vapeador contiene sustancias químicas que pueden afectar el sistema respiratorio y generar dependencia por la nicotina; sin embargo, muchos jóvenes no lo consideran dañino, lo que hace necesario prestar atención a la salud de los adolescentes que lo consumen (Benjoshep, 2026).

Además, el vapeo expone los pulmones a una variedad de productos químicos, entre ellos los principios activos del tabaco o de la marihuana, saborizantes y otros ingredientes añadidos a los líquidos; incluso se generan nuevos compuestos durante el calentamiento. Aunque los dispositivos funcionan de manera similar, algunos son más potentes que otros: producen más vapor y liberan mayor cantidad de sustancias químicas (Eissenberg, 2020).

En el contexto escolar se observa que los estudiantes se acercan al vapeador por curiosidad, por problemas personales, por presión social o por lo que ven en las redes sociales, y que la falta de información clara es uno de los principales obstáculos para su prevención (Ramachandran, 2024).

Por estas razones surge la necesidad de desarrollar estrategias que permitan informar, sensibilizar y orientar a los estudiantes de grado noveno sobre los riesgos del cigarrillo electrónico, de modo que comprendan cuáles son los químicos nocivos que contiene y los daños que puede causar a largo plazo. También se busca fomentar la toma de decisiones responsables y una comunicación respetuosa, mediante actividades e información claras y agradables para cada estudiante, que contribuyan a una sana convivencia en el grado noveno.

Justificación

Este proyecto busca prevenir el consumo del vapeador en los estudiantes de grado noveno, quienes conocen estos dispositivos y se desenvuelven en un entorno social donde su uso se ve como algo normal e incluso inofensivo, lo que lleva a desconocer los daños que pueden producir. La encuesta diagnóstica aplicada respalda esta necesidad: aunque el 95,8 % de los estudiantes sabe qué es un vapeador, el 41,7

% lo considera menos dañino que el cigarrillo tradicional y el 45,8 % afirma no haber recibido información sobre sus riesgos en el colegio.

¿Por qué es importante prevenir el consumo del vapeador?

Porque no es un producto inofensivo: genera daños graves y duraderos en la salud, como afectaciones pulmonares y cardiovasculares y mayor riesgo de infecciones respiratorias, además de consecuencias sociales y económicas. En la adolescencia, la exposición a la nicotina es especialmente delicada, pues puede alterar el desarrollo cerebral y favorecer la dependencia (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2022).

¿Cuál es el beneficio institucional?

Para la institución, el beneficio consiste en contar con medidas y estrategias de prevención que le permitan cumplir la normatividad vigente y proteger a su comunidad educativa. La Ley 2354 de 2024 modificó el artículo 1 de la Ley 1335 de 2009 e incluyó los cigarrillos electrónicos y dispositivos similares dentro de la regulación del tabaco, prohibiendo su venta a menores de edad y su consumo en espacios cerrados (Congreso de Colombia, 2024). Por ello, además de los problemas de salud, el consumo puede acarrear consecuencias legales, y la prevención desde la escuela ayuda a que los estudiantes lo comprendan y tomen decisiones responsables.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una estrategia educativa para prevenir el consumo de vapeadores en estudiantes de grado noveno del Gimnasio Santander.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar el nivel de conocimiento, las creencias y las percepciones que tienen los estudiantes de grado noveno del Gimnasio Santander sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de vapeadores.

2. Analizar los factores personales, sociales, familiares y escolares que favorecen o desincentivan el consumo de estos dispositivos en la población estudiada.
3. Diseñar una estrategia pedagógica de prevención del consumo de vapeadores, adaptada a las características y necesidades identificadas en el diagnóstico realizado.
4. Evaluar la pertinencia, la viabilidad y el potencial impacto preventivo de la estrategia propuesta para su implementación en la institución educativa.

Marco teórico

1. Concepto de vapeador o dispositivo electrónico de calentamiento de tabaco

Los dispositivos electrónicos para el consumo de vapor, comúnmente llamados vapeadores, son aparatos que funcionan con una batería que calienta una solución líquida para generar un aerosol que se inhala. Contrario a la creencia popular, no se trata de una "vaporización pura", sino del calentamiento de sustancias que produce partículas sólidas y gases (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2024). La Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2023) los clasifica en tres grupos:

- **Sistemas cerrados:** con cartuchos prellenados de fábrica.
- **Sistemas abiertos:** el usuario rellena el depósito con líquidos comerciales.
- **Dispositivos de calentamiento de tabaco:** utilizan hojas de tabaco procesadas en lugar de líquidos.

Aunque algunos autores los presentan como alternativas seguras al tabaco tradicional, la mayoría de los organismos sanitarios coincide en que no están exentos de riesgos para la salud (Ministerio de Salud y Protección Social [Minsalud], 2023).

2. Composición química de los líquidos y aerosoles

Los líquidos base suelen contener propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes y, en la mayoría de los casos, nicotina. Sin embargo, al calentarse se liberan sustancias tóxicas que no están presentes en la solución original:

- **Nicotina:** presente en el 80 % de los productos analizados en Colombia, incluso en aquellos etiquetados como “sin nicotina” (Instituto Nacional de Salud [INS], 2024).
- **Compuestos cancerígenos:** como formaldehído, acetaldehído y acroleína, generados por la descomposición térmica de los componentes base (González et al., 2023).
- **Metales pesados:** plomo, níquel y cromo, provenientes de los elementos calefactores del dispositivo (OPS, 2023).

Estos hallazgos contradicen la publicidad comercial que califica los vapeadores como “solo agua y sabor”, pues el aerosol inhalado contiene al menos 25 sustancias de interés toxicológico (OMS, 2024).

3. Efectos en la salud

Los efectos se dividen en agudos y crónicos, y son especialmente graves en los adolescentes, cuyos órganos aún se encuentran en desarrollo.

Efectos agudos

- Irritación de las vías respiratorias, tos y dificultad para respirar.
- Aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.
- Mareos, náuseas y dolor de cabeza por la exposición a nicotina o a sustancias irritantes (Minsalud, 2023).

Efectos crónicos

- Daño irreversible en los alvéolos pulmonares y mayor riesgo de enfermedades respiratorias crónicas, como la bronquitis obstructiva.
- Alteraciones en el desarrollo del cerebro adolescente: afectan la memoria, la concentración y la capacidad de toma de decisiones, y aumentan la vulnerabilidad a otras adicciones en la adultez (APA, 2022).

- Estudios comparativos muestran que quienes consumen vapeadores tienen tres veces más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares que quienes no consumen ningún producto de tabaco (Rodríguez y Méndez, 2025).

4. Adicción a la nicotina

La nicotina es una sustancia psicoactiva que genera dependencia física y psicológica de forma rápida, y su capacidad adictiva es elevada (OMS, 2024). En los vapeadores, la nicotina se presenta en forma de sales, que permiten dosis más altas con menos irritación y facilitan que el cuerpo absorba hasta un 50 % más de sustancia que con el tabaco tradicional (Pérez et al., 2024). Esto explica por qué el 65 % de los adolescentes que probaron el vapeador una vez terminó consumiéndolo de forma habitual (INS, 2024).

La adicción se mantiene por mecanismos de recompensa cerebral: la nicotina activa la liberación de dopamina y genera asociaciones placenteras con el consumo que se refuerzan con el tiempo (APA, 2022).

5. Consumo de vapeadores en adolescentes

El consumo en esta franja de edad ha crecido de forma acelerada en América Latina. Según la OPS (2024), entre 2021 y 2023 el uso aumentó un 32 % en jóvenes de 12 a 17 años, y Colombia fue uno de los países con mayor incremento en la región.

En el contexto nacional, la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE, 2023) reporta que el 18,7 % de los estudiantes de secundaria ha probado un vapeador al menos una vez y que el 7,2 % lo consume de forma regular. Esta tendencia se explica por factores como la percepción de seguridad, la publicidad dirigida a jóvenes y la influencia del grupo de pares (Minsalud, 2023). Además, los adolescentes actuales inician el consumo a edades más tempranas: el promedio de inicio en Colombia es de 13 años (INS, 2024).

6. Factores de riesgo del consumo

Las investigaciones coinciden en que no existe una causa única, sino una combinación de factores, que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1

Factores de riesgo asociados al consumo de vapeadores en adolescentes

Tipo de factor	Descripción y evidencia
Individuales	Falta de información sobre los riesgos, búsqueda de identidad y sensación de autonomía, y antecedentes de consumo en la familia (García et al., 2023).
Sociales	Influencia de amigos y compañeros, presión grupal y uso por parte de figuras cercanas, como familiares o influenciadores en redes sociales (OPS, 2023).
Comerciales	Publicidad que resalta sabores atractivos (frutas, dulces), diseños modernos y la idea de que el producto es “menos dañino” (Minsalud, 2023).
Escolares	Baja implementación de programas de prevención y falta de espacios para hablar del tema con claridad (López y Ruiz, 2025).

7. Estrategias de prevención en entornos escolares

Las intervenciones exitosas no se limitan a informar sobre los daños, sino que combinan información científica, desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y participación de la comunidad educativa:

- **Modelos basados en evidencia:** los programas que integran actividades prácticas, talleres y trabajo con las familias han logrado reducir hasta en un 40 % el inicio del consumo en las escuelas donde se aplicaron (OPS, 2024).
- **Participación activa frente a las charlas unidireccionales:** las estrategias que invitan a los estudiantes a reflexionar, debatir y crear sus propios mensajes preventivos tienen mayor impacto a largo plazo (Mendoza et al., 2025).
- **Normativas escolares:** complementan la educación con reglas claras sobre la prohibición de estos dispositivos dentro de la institución y con rutas de apoyo para quienes ya presentan un consumo frecuente (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2024).

Marco conceptual

1. Vapeador o sistema electrónico de administración de nicotina (SEAN). Aparato que utiliza una fuente de energía para calentar una solución líquida y

generar un aerosol que se inhala. No se trata de vapor de agua, sino de una mezcla de sustancias que pueden incluir nicotina, propilenglicol, glicerina, saborizantes y compuestos tóxicos (Minsalud, 2023). En Colombia, la Ley 2354 de 2024 lo incluye en la regulación de los productos de tabaco y prohíbe su venta a menores de edad (Congreso de Colombia, 2024).

2. Nicotina. Sustancia psicoactiva presente en la mayoría de los vapeadores, incluso en aquellos etiquetados como “sin nicotina”. Actúa sobre el sistema nervioso central y produce efectos rápidos en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de dopamina, lo que facilita la aparición de dependencia (Minsalud, 2024).

3. Adicción. Enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central, caracterizada por la búsqueda compulsiva de una sustancia, la pérdida de control sobre su consumo y la persistencia en su uso a pesar de conocer sus consecuencias negativas. Implica alteraciones en los circuitos cerebrales de recompensa, aprendizaje y toma de decisiones (APA, 2022).

4. Adolescencia. Etapa del desarrollo humano que transcurre aproximadamente entre los 10 y los 19 años, marcada por profundos cambios biológicos, psicológicos y sociales. Es un periodo clave en la formación de la identidad, la consolidación de hábitos y la maduración del cerebro, por lo que la exposición a sustancias como la nicotina genera impactos más duraderos que en la adultez (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2023).

5. Efectos en la salud. Consecuencias derivadas de la exposición al aerosol de los vapeadores, que incluyen efectos agudos, como irritación respiratoria, mareos y aumento de la frecuencia cardíaca, así como daños crónicos en los pulmones, alteraciones en el desarrollo cerebral y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de adicciones múltiples (APA, 2022).

6. Factores de riesgo y de protección. Los factores de riesgo son características o condiciones personales, sociales, familiares o escolares que aumentan la probabilidad de iniciar o mantener el consumo de sustancias; entre ellos destacan la presión de pares, la falta de información, la publicidad dirigida y el fácil acceso a los dispositivos (Minsalud, 2023). Los factores de protección son elementos que

reducen la vulnerabilidad al consumo, como el pensamiento crítico, los vínculos familiares sólidos, los hábitos saludables y los programas escolares de prevención (MEN, 2024).

7. Prevención escolar. Conjunto de acciones educativas, pedagógicas y organizativas desarrolladas en la institución educativa para evitar el inicio del consumo, reducir sus daños y fortalecer competencias en los estudiantes. No se limita a transmitir información: promueve la reflexión, el desarrollo de habilidades y la participación de toda la comunidad educativa (MEN, 2024).

8. Estrategia pedagógica. Plan de acción estructurado, fundamentado en evidencia y adaptado a las necesidades del grupo, que integra objetivos, contenidos, actividades y recursos para lograr cambios en conocimientos, actitudes y conductas. En este proyecto se orienta a prevenir el consumo de vapeadores en los estudiantes de grado noveno (Mendoza et al., 2025).

Marco metodológico

Enfoque y diseño de la investigación

La metodología de investigación es el componente que orienta, de manera ordenada y estructurada, la forma en que se realiza un estudio: define las estrategias, las técnicas y los procedimientos que se emplean tanto en el diseño de la investigación como en la recolección de la información (Hernández-Flores, 2025).

Este proyecto adopta un **enfoque mixto**. El componente cuantitativo mide variables numéricas y las presenta mediante porcentajes y gráficas; en este proyecto se concreta en la encuesta diagnóstica. El componente cualitativo busca comprender el fenómeno desde la perspectiva de los participantes; aquí se concreta en la observación de las actividades y en el análisis de las producciones de los estudiantes (hojas de mitos y realidades). El diseño es **exploratorio y descriptivo**: exploratorio, porque se indaga lo que los estudiantes saben y creen sobre el

vapeador, y descriptivo, porque se detallan las características de ese conocimiento y de los factores que lo rodean.

Técnicas y instrumentos

- **Encuesta diagnóstica:** cuestionario de 12 preguntas aplicado mediante Google Forms (Anexo A).
- **Encuesta final:** cuestionario de 12 preguntas (10 cerradas y 2 abiertas) aplicado mediante Google Forms para evidenciar los conocimientos logrados con las actividades (Anexo C).
- **Observación participante y registro fotográfico** durante cada una de las actividades.
- **Análisis de producciones de los estudiantes:** hojas de trabajo con cinco mitos y cinco realidades sobre el vapeador.

Población y muestra

La población de este proyecto son los estudiantes de grado noveno del Colegio Gimnasio Santander, de la ciudad de Tunja, con edades entre los 13 y los 15 años. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes seleccionados para el desarrollo del proyecto, de los cuales 25 respondieron la encuesta diagnóstica (7 de 13 años, 12 de 14 años y 5 de 15 años). La encuesta final fue respondida por 25 estudiantes (la pregunta 8 registró 25 respuestas).

Para la participación en las actividades se tuvo en cuenta un requisito fundamental: el consentimiento informado para la toma de fotografías, firmado por los padres de familia o acudientes. Con base en lo anterior, el desarrollo del proyecto se organizó en las siguientes etapas:

1. **Autorizaciones.** Consentimiento firmado por los padres o acudientes para la toma de fotografías en grado noveno y autorización de la rectora para invitar a otra institución a dar charlas sobre el tema.

2. **Encuesta inicial.** Aplicación de un cuestionario para identificar los conocimientos y las creencias de los estudiantes y establecer su nivel de partida.
3. **Sesiones de prevención.** Charlas y actividades participativas para que los estudiantes tomen conciencia de la situación y cuenten con información veraz.
4. **Registro de evidencias.** Documentación fotográfica y de las producciones de cada sesión, para sistematizar la información de manera ordenada.
5. **Encuesta final:** Elaboración de esta encuesta para ver observar y sacar análisis del antes y el después del conocimiento hacia el vaper y así obtener unos buenos resultados

Las variables de estudio y sus indicadores se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2

Variables de estudio, definición e indicadores

Variable	Definición	Indicador
Conocimientos sobre el vapeador	Información que tienen los estudiantes sobre qué es el vapeador, qué contiene y qué daños puede causar.	Preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta inicial; preguntas 2, 4 y 5 de la final; actividades de mitos y realidades.
Actitudes y creencias	Opiniones y percepciones frente al vapeo: si se considera menos dañino que el cigarrillo, si las redes sociales influyen y si debería prohibirse a menores.	Preguntas 5, 8 y 12 de la encuesta inicial; preguntas 3, 9 y 10 de la final; categoría “depende” en el semáforo.
Exposición al vapeo	Contacto de los estudiantes con vapeadores en su entorno: amigos que los usan y ofrecimientos para probarlos. No se indagó el consumo propio.	Preguntas 6 y 7 de la encuesta inicial; preguntas 7 y 8 de la final.
Estrategia de intervención preventiva	Conjunto de actividades (dinámicas, charla, encuesta) orientadas a informar, generar reflexión y promover decisiones responsables frente al vapeo.	Preguntas 9, 10 y 11 de la encuesta inicial; preguntas 1, 11 y 12 de la final; participación y producciones de los estudiantes.

Para organizar el trabajo se elaboró un cronograma con el mes, la actividad y la institución donde se realizó cada una (Tabla 3).

Tabla 3

Cronograma de actividades del proyecto

Mes	Actividad	Institución
Marzo de 2026	Encuesta inicial (diagnóstico) a los estudiantes de grado noveno, aplicada mediante Google Forms.	Colegio Gimnasio Santander
Septiembre de 2026	**Actividad 1** (10 de septiembre, 2:00 p. m.): dinámicas “No al vaper”, mitos y realidades, y charadas, en el espacio de Semillero, Familia, Cultura y Territorio.	Colegio Gimnasio Santander
Septiembre de 2026	**Actividad 2** (14 de septiembre, 4:00 p. m.): charla introductoria y semáforo de mitos y realidades.	Colegio Gimnasio Santander
Octubre de 2026	**Actividad 3** (1 de octubre, 2:00 p. m.): espacio de Semillero, Familia, Cultura y Territorio.	Colegio Gimnasio Santander
Octubre de 2026	Encuesta final, aplicada mediante Google Forms para evidenciar los conocimientos logrados.	Colegio Gimnasio Santander

Análisis y resultados

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta diagnóstica y de las actividades realizadas hasta la fecha, analizados a partir de las variables del estudio: conocimientos, actitudes y creencias, exposición al vapeo y estrategia de intervención. Los datos de la encuesta se organizan en tablas y figuras; los de las actividades se describen e interpretan a partir de la observación y de las producciones de los estudiantes, y se contrastan con el marco teórico. Como punto de partida, la información obtenida permite identificar no solo lo que los estudiantes saben, sino también lo que creen y desconocen, que es lo que orienta el diseño de las estrategias preventivas.

Actividad previa: autorizaciones

Antes de iniciar las actividades se entregaron las autorizaciones para la toma de fotografías, que debían ser firmadas por los padres de familia o acudientes. Este paso es necesario desde el punto de vista ético, pues se trabaja con menores de edad: garantiza que las familias conozcan el proyecto y consientan el registro de

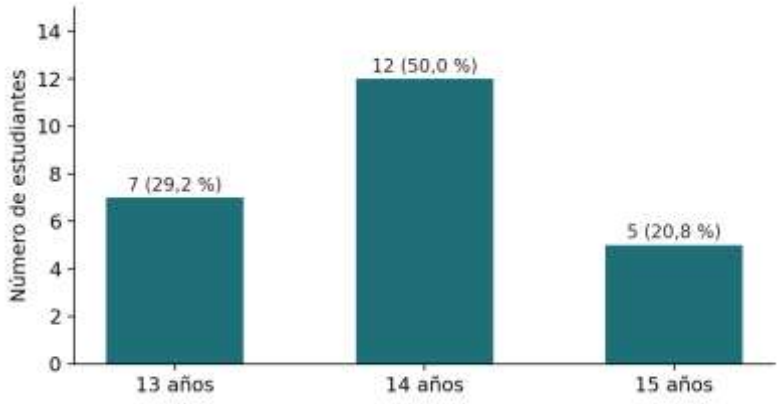
evidencias, y permite documentar el proceso sin vulnerar la privacidad de los estudiantes. Una vez recibidas las autorizaciones firmadas, se dio inicio a las actividades.

Diagnóstico inicial: encuesta a los estudiantes de grado noveno

La encuesta diagnóstica, de 12 preguntas, permitió responder al primer objetivo específico. La Figura 1 muestra que el grupo estuvo conformado por estudiantes de 13 a 15 años, con predominio de los de 14 años (50 %), lo que coincide con la edad de inicio de consumo reportada en Colombia, cercana a los 13 años (INS, 2024). Esto confirma que la intervención llega al grupo en el momento en que el riesgo de iniciación es más relevante.

Figura 1

Distribución de los estudiantes encuestados según la edad



Conocimientos y percepción del riesgo

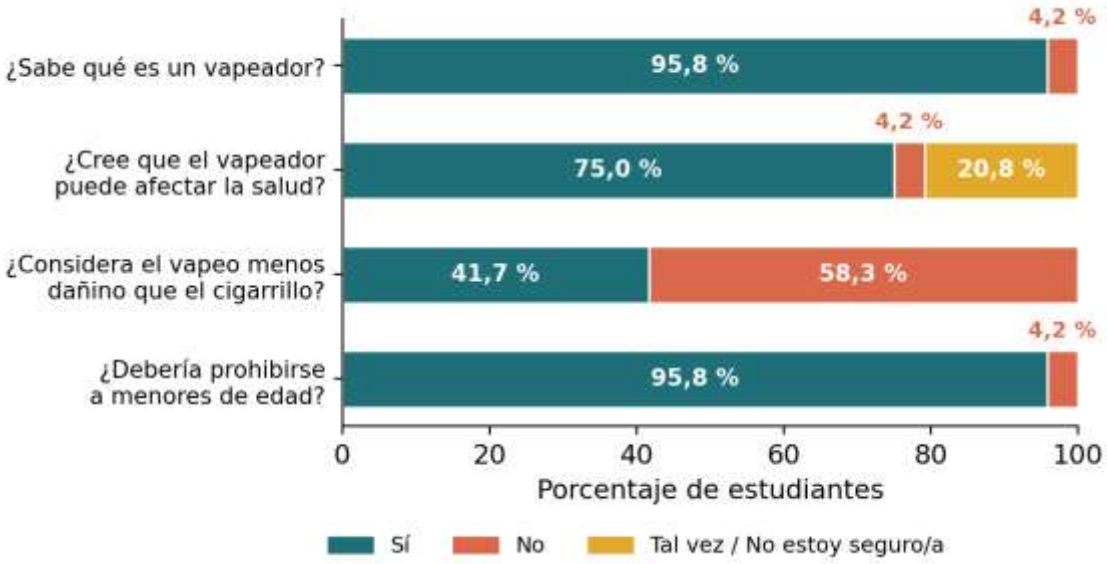
Como se observa en la Figura 2, el 95,8 % de los estudiantes (23 de 25) sabe qué es un vapeador y el 75 % (18) cree que puede afectar la salud; el 20,8 % (5) no está seguro y el 4,2 % (1) considera que no. Esto indica que el conocimiento del dispositivo es casi general, pero la comprensión de sus riesgos aún no lo es: una cuarta parte del grupo no tiene una opinión clara o descarta el daño.

Más significativo es que el 41,7 % (10 estudiantes) considera el vapeo menos dañino que el cigarrillo tradicional. Esta creencia coincide con la percepción de seguridad que Minsalud (2023) señala como uno de los factores que explican el aumento del consumo, y con la publicidad que presenta el producto como “menos

dañino”. Por otra parte, el 95,8 % opina que los vapeadores deberían prohibirse a menores de edad, lo que refleja una actitud favorable a la regulación que puede aprovecharse como punto de apoyo en la estrategia.

Figura 2

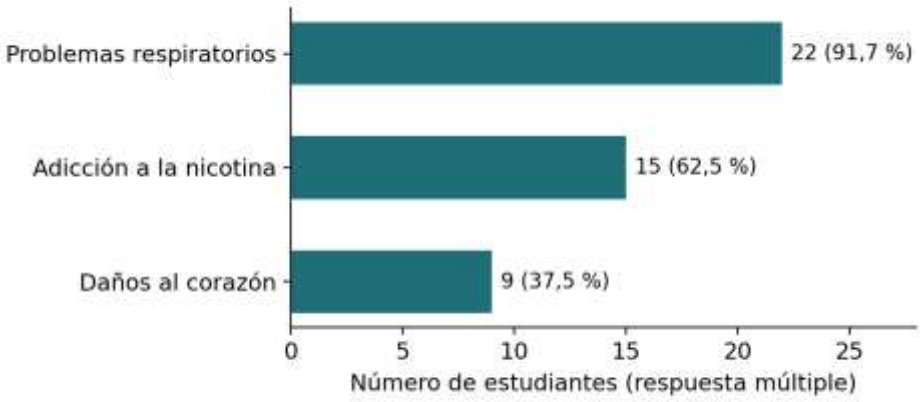
Conocimientos, percepción del riesgo y actitud frente a la regulación



En cuanto a los daños que los estudiantes reconocen (Figura 3), los problemas respiratorios son los más identificados (91,7 %), seguidos por la adicción a la nicotina (62,5 %) y los daños al corazón (37,5 %). Ningún estudiante marcó las opciones “no causa ningún daño” o “no sé”, de modo que existe conciencia general de que el vapeo hace daño. La brecha está en los efectos cardiovasculares, que son los menos reconocidos pese a que la literatura los señala como un riesgo relevante (Rodríguez y Méndez, 2025); por ello, este contenido debe reforzarse en las charlas.

Figura 3

Daños que los estudiantes creen que puede causar el vapeo



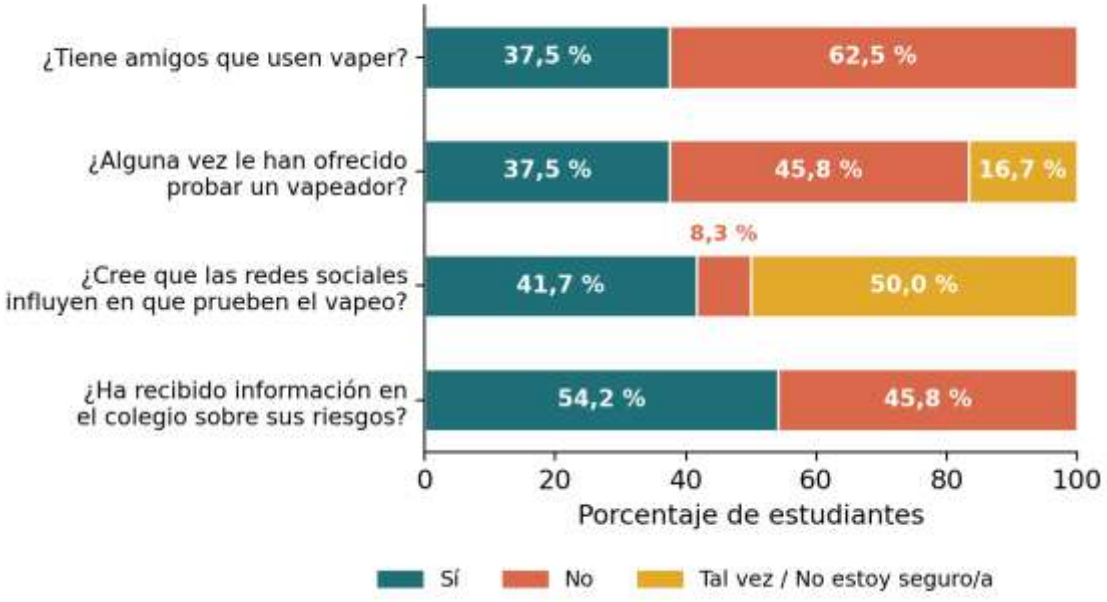
Exposición, entorno e información recibida

La Figura 4 muestra que el 37,5 % de los estudiantes (9) tiene amigos que usan vaper, que al 37,5 % (9) alguna vez le han ofrecido probar un vapeador y que otro 16,7 % (4) respondió “tal vez”. Es decir, cerca de cuatro de cada diez estudiantes ya ha estado expuesto a la oferta directa de estos dispositivos, lo que confirma el papel de la influencia de los pares como factor social de riesgo (OPS, 2023). Asimismo, solo el 41,7 % cree con certeza que las redes sociales influyen en que los jóvenes prueben el vapeo, mientras que la mitad (50 %) responde “tal vez”; esta ambigüedad sugiere que los estudiantes todavía no identifican con claridad cómo la publicidad y las redes normalizan el consumo.

Respecto a la información recibida, el 54,2 % (13) afirma haber recibido información sobre los riesgos del vapeo en el colegio, pero el 45,8 % (11) dice que no. Casi la mitad del grupo carece, entonces, de espacios formales para tratar el tema, lo que corresponde al factor de riesgo escolar descrito por López y Ruiz (2025) y justifica la necesidad de la estrategia. Cabe aclarar que la encuesta no indagó el consumo propio, por lo que los datos describen exposición y percepciones, pero no la prevalencia de consumo en el grupo.

Figura 4

Exposición al vapeo, influencia de las redes sociales e información recibida en el colegio

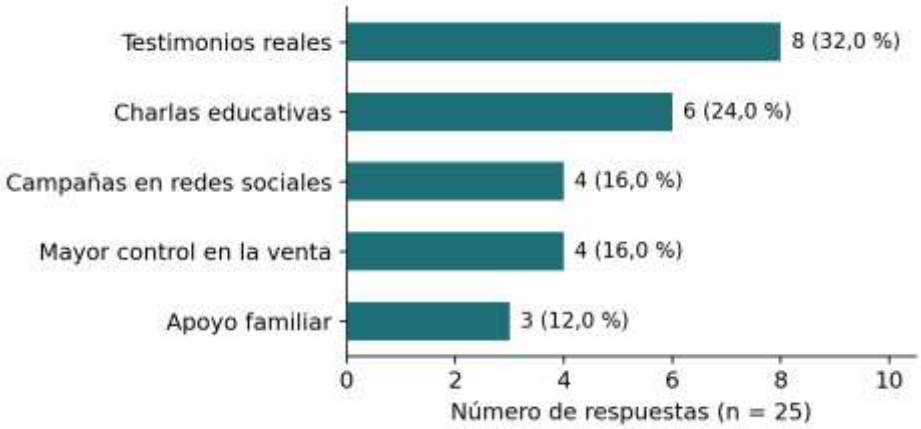


Estrategias que los estudiantes consideran más efectivas

El 66,7 % de los estudiantes (16) manifestó que le gustaría recibir más charlas o campañas informativas sobre el tema, frente al 33,3 % (8) que no. Cuando se les preguntó qué sería más efectivo para prevenir el uso del vapeador en jóvenes (Figura 5), la opción más votada fue la de los testimonios reales (32 %), seguida por las charlas educativas (24 %); las campañas en redes sociales y el mayor control en la venta obtuvieron 16 % cada una, y el apoyo familiar, 12 %. Estos resultados muestran que los estudiantes valoran los mensajes cercanos y basados en experiencias reales y la información presentada de forma directa, lo que respalda el diseño de una estrategia que combine charlas, actividades participativas y una campaña elaborada por ellos mismos, en línea con lo planteado por Mendoza et al. (2025).

Figura 5

Estrategias que los estudiantes consideran más efectivas para prevenir el uso del vapeador



La Tabla 4 sintetiza los hallazgos del diagnóstico y la forma en que cada uno orienta la estrategia.

Tabla 4

Síntesis de los hallazgos del diagnóstico y su implicación para la estrategia

Hallazgo del diagnóstico	Implicación	Actividad que responde
El 95,8 % sabe qué es un vapeador, pero el 25 % no tiene una opinión clara sobre su daño.	El conocimiento es general pero superficial; se necesita profundizar en contenidos específicos.	Actividad 2: charla informativa.
El 41,7 % cree que el vapeo es menos dañino que el cigarrillo.	Existe una creencia errónea que debe confrontarse con evidencia.	Actividades 1 y 2: mitos y realidades.
El 37,5 % tiene amigos que vapean y al 37,5 % le han ofrecido probar.	Hay exposición real en el entorno; se requieren habilidades para decir no.	Actividades 1, 3 y 4: dinámicas grupales.
El 45,8 % no ha recibido información en el colegio.	Existe un vacío institucional que debe cubrirse.	Actividad 2 y campaña final.
El 66,7 % desea más charlas; los testimonios (32 %) y las charlas (24 %) son lo más valorado.	Hay disposición de los estudiantes y preferencia por mensajes cercanos.	Actividad 5: video y campaña.

Actividad 1 (10 de septiembre de 2026): dinámicas “No al vaper”, mitos y realidades y charadas

Propósito. Identificar de forma lúdica las creencias y los conocimientos previos de los estudiantes y generar un clima de confianza para hablar del vapeo sin juicios.

Desarrollo. La actividad se realizó a las 2:00 p. m., en el espacio de Semillero, Familia, Cultura y Territorio. La sesión se organizó en tres dinámicas de 20 minutos cada una: (1) “No al vaper”, dinámica de apertura y sensibilización; (2) “Mitos y realidades”, en la que los estudiantes ubicaron afirmaciones sobre el vapeador como mito, realidad o “depende” y pegaron sus aportes en un mural; y (3) “Charadas”, en las que representaron mediante mímica conceptos relacionados con el vapeo.

Fundamento. Se eligieron dinámicas participativas porque las estrategias que invitan a los estudiantes a reflexionar, debatir y crear sus propios mensajes tienen mayor impacto a largo plazo que las charlas unidireccionales (Mendoza et al., 2025), y porque los programas que combinan actividades prácticas y talleres logran reducir el inicio del consumo (OPS, 2024). Además, la categoría “depende” permite que

afloren las dudas sin exigir una respuesta correcta, algo relevante si se tiene en cuenta que el 20,8 % de los estudiantes no estaba seguro de que el vapeador afectara la salud.

Resultados y análisis. Los estudiantes participaron en las tres dinámicas y mostraron que reconocen el dispositivo y varias de sus consecuencias, lo que concuerda con el diagnóstico, en el que el 95,8 % afirmó saber qué es un vapeador. Sin embargo, las dudas que se expresaron en la categoría “depende” y la creencia de que el vapeo es menos dañino (41,7 %) indican que el conocimiento es amplio pero superficial. Por ello es necesario seguir reforzando el tema con contenidos específicos composición del líquido, efectos de la nicotina y consecuencias a largo plazo, que se abordaron en la segunda actividad. Además, la dimensión lúdica favoreció que los estudiantes comprendieran, de forma más cercana, las consecuencias del vapeo en la salud física y mental.

Figura 6

Presentación de la actividad 1



Figura 7

Primera dinámica: “No al vaper”





Figura 8

Segunda dinámica: “Mitos y realidades”





Figura 9

Tercera dinámica: “Charadas”





Figura 10

Evidencias de la actividad 1: mural de mitos y realidades y tarjetas “depende”









Actividad 2 (14 de septiembre de 2026): charla introductoria y semáforo de mitos y realidades

Propósito. Brindar información científica clara sobre qué es el vapeador, su estructura y funcionamiento, la composición del líquido y sus efectos en la salud, y contrastarla con las creencias de los estudiantes mediante el semáforo de mitos y realidades.

Desarrollo. La actividad se realizó a las 4:00 p. m. Primero se dio una charla introductoria sobre qué es el vapeador, su estructura y funcionamiento, la composición del líquido, los efectos en la salud y la forma de prevenirlo. Luego, en el semáforo de mitos y realidades, los estudiantes leyeron frases y las clasificaron en tres categorías: mito, “no es totalmente cierta, pero hay que tener cuidado” y realidad. Para finalizar, cada estudiante escribió cinco mitos y cinco realidades a partir de lo aprendido.

Fundamento. La charla responde a la falta de información detectada en el diagnóstico (45,8 % no ha recibido información en el colegio) y a la preferencia de los estudiantes por las charlas educativas (24 %). El semáforo evita que la sesión sea unidireccional: obliga a los estudiantes a evaluar afirmaciones y a justificar su clasificación, lo que desarrolla el pensamiento crítico y permite corregir creencias erróneas, como la idea de que el vapeo es “solo agua con sabor”, que la OMS (2024) desmiente al señalar que el aerosol contiene partículas y sustancias tóxicas. La tarea de escribir mitos y realidades convierte a los estudiantes en productores de mensajes preventivos, una característica de las estrategias con mayor impacto (Mendoza et al., 2025), y sirve a la vez como evidencia de aprendizaje.

Resultados y análisis. En la clasificación de frases, alrededor del 25 % de los estudiantes coincidió en identificar como realidad que “los saborizantes son dañinos” y como mito que “el vaper no contiene nicotina”. En las hojas de trabajo se repitieron mitos que coinciden con las creencias detectadas en el diagnóstico por ejemplo, que el vapeo no es dañino, que es solo agua con sabor, que no produce adicción o que es menos dañino que el cigarrillo, junto con realidades que muestran que los estudiantes lograron refutarlos, como que la nicotina genera dependencia, que afecta el cerebro y que daña los pulmones (Tabla 5). Esto evidencia que la actividad cumplió su función de transformar creencias previas en argumentos informados.

Tabla 5

Mitos recurrentes en las hojas de trabajo y la realidad que los desmiente

Mito (creencia previa)	Realidad que lo desmiente
“El vaper no hace tanto daño” / “no es dañino”.	Afecta los pulmones y el cerebro (APA, 2022; Minsalud, 2023).
“Es solo agua con sabor”; “no contiene sustancias químicas”.	El aerosol no es vapor de agua y los saborizantes son dañinos (OMS, 2024).
“Algunos vapers no tienen nicotina”; “no contiene nicotina”.	La mayoría contiene nicotina, incluso algunos etiquetados como “sin nicotina” (INS, 2024).
“El vaper no produce adicción”.	La nicotina genera dependencia (APA, 2022).
“Es menos dañino que el cigarrillo”.	No es inofensivo ni está exento de riesgos (Minsalud, 2023).
“Es legal para los menores de edad”.	Su venta a menores de edad está prohibida (Congreso de Colombia, 2024).

Un aspecto por mejorar es que algunos estudiantes escribieron como realidad que el vapeador es “más dañino” que el cigarrillo tradicional. La evidencia disponible permite afirmar que no es inocuo ni “menos dañino” sin riesgos, pero no justifica una comparación tajante; por eso, en las sesiones siguientes conviene afinar el mensaje preventivo hacia “no es una alternativa segura”. El cambio en los conocimientos y las creencias se valora con la encuesta final, que se presenta más adelante.

Figura 11

Trabajo de los estudiantes durante la actividad 2





Figura 12

Semáforo de mitos y realidades y escritura de las hojas de trabajo

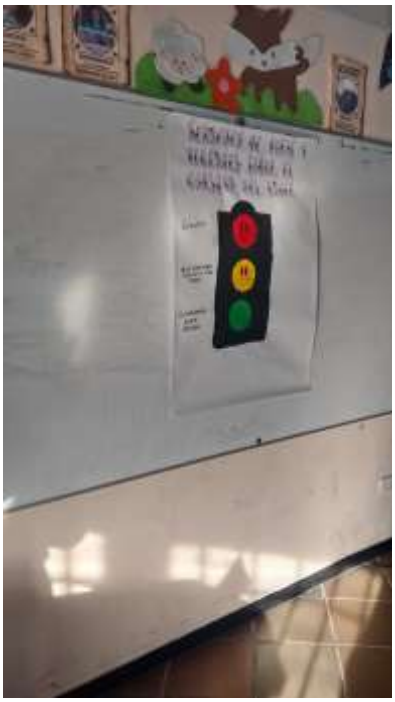
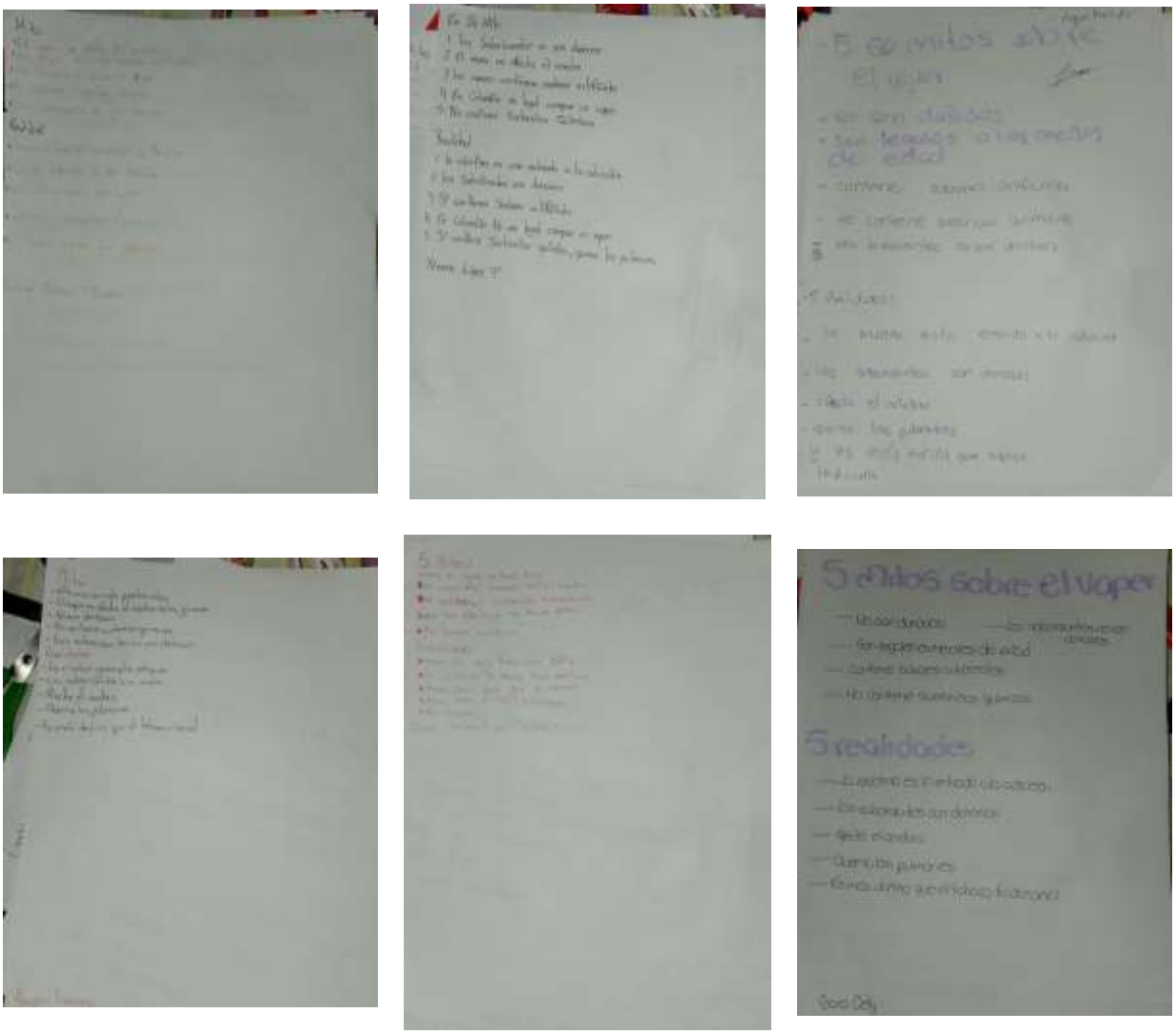
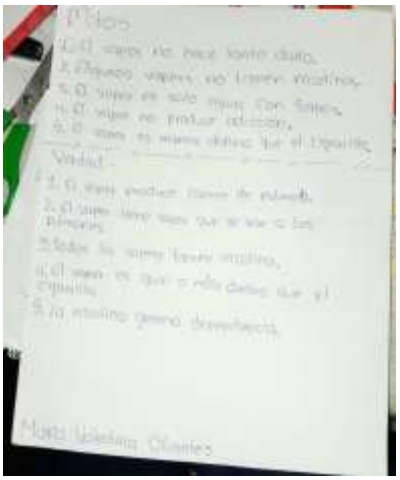
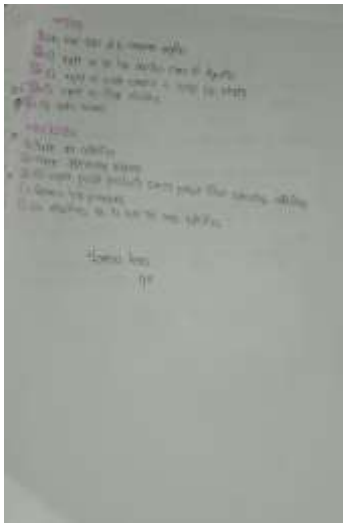


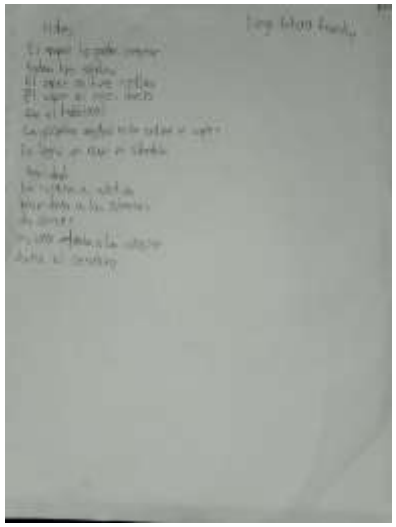
Figura 13

Hojas de trabajo de los estudiantes: cinco mitos y cinco realidades









Actividad 3 (1 de octubre de 2026) dinámica grupal en circulo y trabajo por grupos





Tabla 6

Actividades 3, 4.

Actividad	Fecha y hora	Propósito y fundamento	Resultados
Actividad 3	1 de octubre, 2:00 p. m. (Semillero, Familia, Cultura y Territorio)	En esta parte de la segunda sesión se quería evidenciar la ética y empatía de los estudiantes al momento de actuar sobre una información sobre el vaper.	Se vio el compromiso de todos los estudiantes.
Actividad 5	22 de octubre, 7:30 a.m. (encuesta final)	Para finalizar realice una encuesta para mirar los resultados obtenidos durante cada fecha de actividades y los estudiantes respondieron conscientemente cada una.	Se reflejo una buena disposición por cada uno.

Encuesta final: resultados y comparación con el diagnóstico

Para evidenciar el conocimiento que lograron los estudiantes con las actividades en las que participaron, se aplicó una encuesta final de 12 preguntas mediante Google Forms, respondida por 25 estudiantes (la pregunta 8 registró 24 respuestas). A diferencia de la encuesta inicial, esta indaga con mayor detalle los conocimientos específicos (sustancias, adicción, nicotina), el papel de los sabores, la reacción ante una oferta de consumo y la valoración de las actividades. Por ello, solo cuatro de sus indicadores pueden contrastarse con el diagnóstico, y dos de ellos con una redacción distinta.

Conocimientos y creencias de las activiades

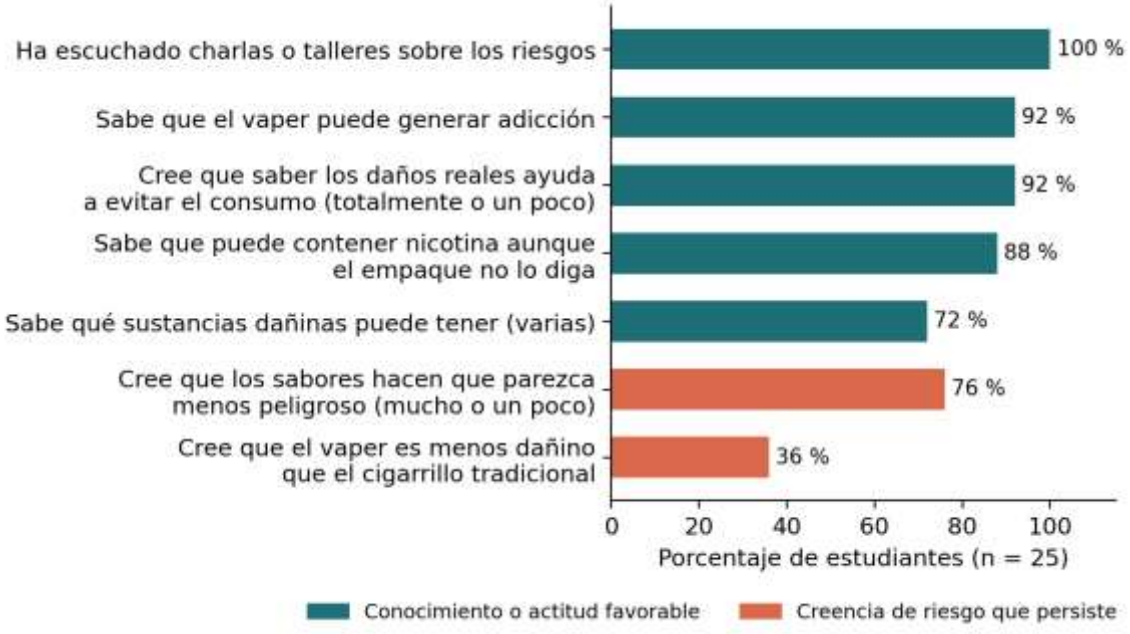
Como muestra la Figura 14, el 100 % de los estudiantes (25) afirma haber escuchado charlas o talleres sobre los riesgos del vaper en el colegio; el 92 % (23) sabe que puede generar adicción, el 88 % (22) sabe que puede contener nicotina, aunque el empaque no lo indique y el 72 % (18) dice conocer varias de las sustancias dañinas que puede tener (el 28 %, es decir 7 estudiantes, conoce pocas y ninguno respondió no saber nada). Además, el 92 % cree que conocer los daños reales ayuda a evitar el consumo (52 % totalmente y 40 % un poco), lo que respalda

el enfoque informativo de la estrategia. En cuanto a los efectos en la salud, el 92 % (23) señaló el daño en pulmones y respiración como el principal.

Persisten, sin embargo, dos creencias que conviene atender. El 36 % (9 estudiantes) todavía considera que el vaper es menos dañino que el cigarrillo tradicional (el 60 % opina que no y el 4 % dice no saber), y el 76 % cree que los sabores hacen que parezca menos peligroso (44 % “mucho” y 32 % “un poco”). Esto coincide con lo señalado por Minsalud (2023) sobre la publicidad y los sabores atractivos como factores de riesgo. Por último, el 87,5 % (21 de 24) considera que quienes más influyen para que los jóvenes usen vaper son los amigos y compañeros, y el 12,5 % (3) las personas que se ven en redes sociales; ninguno eligió la publicidad. Este resultado reafirma el peso de la influencia de los pares (OPS, 2023).

Figura 14

Indicadores de la encuesta final sobre conocimientos y creencias



Comparación entre la encuesta inicial y la encuesta final

La Figura 15 y la Tabla 7 contrastan los indicadores comparables. Los dos primeros tienen una redacción equivalente; los marcados con asterisco corresponden a

preguntas distintas y deben leerse como una tendencia, no como una medición exacta.

Figura 15

Comparación de indicadores entre la encuesta inicial y la encuesta final

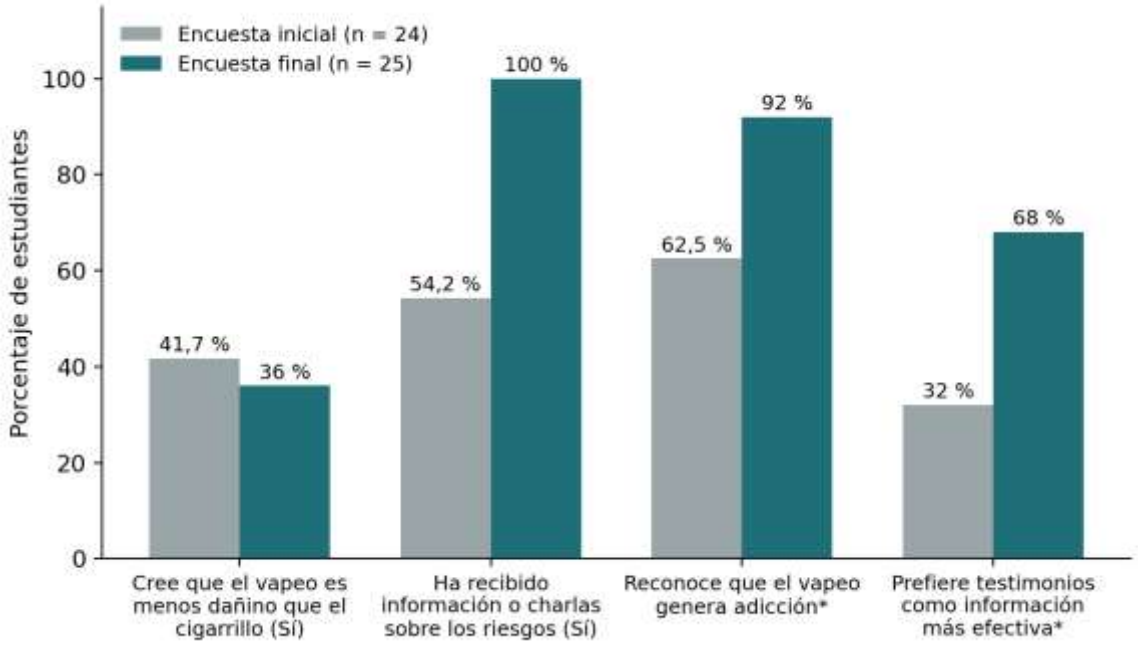


Tabla 7

Cambio en los indicadores entre la encuesta inicial y la final

Indicador	Inicial (%)	Final (%)	Cambio (pp)	Tipo de comparación
Cree que el vapeo es menos dañino que el cigarrillo (Sí)	41,7	36,0	−5,7	Directa
Ha recibido información o charlas sobre los riesgos (Sí)	54,2	100,0	+45,8	Directa parcial
Reconoce que el vapeo genera adicción*	62,5	92,0	+29,5	Indicativa
Prefiere testimonios como información más efectiva*	32,0	68,0	+36,0	Indicativa

Información recibida. El porcentaje pasó de 54,2 % a 100 % (+45,8 puntos): todos los estudiantes reconocen haber recibido charlas o talleres, frente al 45,8 % que en

el diagnóstico decía no haber recibido información. Esto confirma que las actividades llegaron a todo el grupo y cubrieron el vacío institucional identificado. Debe tenerse en cuenta que esta pregunta se respondió después de las actividades, por lo que mide sobre todo la cobertura de la intervención y no un cambio en el conocimiento.

Creencia de que es menos dañino. Disminuyó de 41,7 % a 36 % (−5,7 puntos). Con grupos de 24 y 25 estudiantes, esta diferencia equivale a uno o dos estudiantes y no permite afirmar un cambio sustancial: es la creencia más resistente y requiere reforzarse en las actividades siguientes, por ejemplo, con evidencia sobre los componentes del aerosol y sus riesgos (OMS, 2024).

Reconocimiento de la adicción. En el diagnóstico, el 62,5 % incluyó la adicción entre los daños del vapeo; en la encuesta final, el 92 % afirma saber que puede generar adicción. Aunque las preguntas difieren, la tendencia sugiere una mayor conciencia de la dependencia por nicotina, tema trabajado en la charla informativa (APA, 2022).

Preferencia por los testimonios. La opción de testimonios pasó de 32 % (qué sería más efectivo) a 68 % (qué información llama más la atención). Las preguntas son distintas, pero ambas apuntan en la misma dirección: los estudiantes se sienten más interpelados por mensajes cercanos y basados en experiencias reales. Este resultado sustenta la campaña final (Actividad 5), construida con mensajes propios de los estudiantes (Mendoza et al., 2025).

Indicadores que no se comparan. La pregunta sobre los daños (respuesta múltiple en la encuesta inicial y de respuesta única en la final) y la de influencia (redes sociales frente a amigos, redes y publicidad) cambian de formato o de enfoque, por lo que no se contrastaron. Aun así, en ambas el entorno de pares aparece como relevante.

Limitaciones. Se trata de una comparación descriptiva de porcentajes: no se aplicó una prueba estadística y no es posible confirmar que respondieron exactamente los mismos estudiantes en ambas encuestas, por lo que no se evalúa el cambio individual. Los resultados se interpretan, por tanto, como tendencias del grupo.

Reacción ante una oferta de consumo (pregunta 7)

Las 25 respuestas abiertas se codificaron en categorías (Tabla 8). El 92 % (23 estudiantes) expresó rechazo o no consumo: 11 dicen que no sin más, 5 lo rechazan con un argumento de salud, miedo o familia, 2 se alejan, 3 indican que no consumen o no les interesa y 2 lo rechazarían, aunque sientan curiosidad. Un estudiante respondió “lo pensaría” (4 %) y otro manifestó sorpresa y molestia, sin precisar su decisión. Los argumentos de salud (“sé que es dañino”, “no quiero dañar mi cuerpo”) y de familia (“no quisiera decepcionar a mi familia”) sugieren que los estudiantes están interiorizando factores de protección (MEN, 2024). La curiosidad, señalada por Ramachandran (2024) como una de las razones de acercamiento, aparece en dos respuestas, lo que confirma que sigue presente y que debe trabajarse con habilidades para decir no.

Tabla 8

Reacción de los estudiantes ante una oferta de vaper

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Rechazo directo (“no gracias”, “no lo aceptaría”)	11	44 %
Rechazo con argumento de salud, miedo o familia	5	20 %
No consume o no le interesa	3	12 %
Rechazo y se aleja de la persona	2	8 %
Rechaza, aunque siente curiosidad	2	8 %
Reacción emocional (sorpresa, molestia)	1	4 %
Duda (“lo pensaría”)	1	4 %
Total	**25**	**100 %**

Valoración de las actividades (pregunta 12)

Se analizaron las 23 respuestas de texto disponibles de la pregunta 12. Todas son favorables. Trece (56,5 %) mencionan que aprendieron, comprendieron mejor los riesgos o reforzaron su conocimiento; siete (30,4 %) destacan que las actividades fueron dinámicas, lúdicas, divertidas o interactivas (algunas respuestas mencionan

ambos aspectos); y cinco solo expresan agrado sin justificarlo. Un estudiante señaló que aprendió “como cuidarme del vaper y no dejarme llevar” cuando sus compañeros se lo ofrezcan, lo que evidencia que lo aprendido se transfiere a una situación real. Estas valoraciones respaldan el fundamento de la estrategia: las dinámicas participativas favorecen el aprendizaje y la apropiación del mensaje preventivo (Mendoza et al., 2025).

Análisis integrado

La lectura conjunta del diagnóstico, de las actividades y de la encuesta final permite sostener cuatro ideas. Primero, el conocimiento pasó de ser amplio pero superficial a ser más claro en aspectos clave: el 92 % sabe que el vaper genera adicción, el 88 % que puede contener nicotina, aunque el empaque no lo diga y el 92 % cree que conocer los daños ayuda a evitar el consumo. Segundo, hay creencias que persisten: el 36 % aún considera el vapeo menos dañino que el cigarrillo y el 76 % cree que los sabores lo hacen parecer menos peligroso. Tercero, el entorno de pares sigue siendo determinante (87,5 % señala a los amigos como principal influencia y el 37,5 % ya había recibido ofrecimientos), pero el 92 % rechazaría una oferta, lo que indica que cuentan con recursos para decir no. Cuarto, la estrategia fue bien valorada: todos reportan haber recibido charlas, todas las valoraciones fueron positivas y los testimonios son el tipo de información que más llama la atención (68 %), lo que orienta la campaña final.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos hasta la fecha (encuesta inicial, actividades 1 y 2, 3 y encuesta final), se formulan las siguientes conclusiones, organizadas según los objetivos específicos.

1. **Diagnóstico (objetivo 1).** Los estudiantes conocen el vapeador (95,8 %), pero su conocimiento es amplio y superficial: el 41,7 % lo considera menos dañino que el cigarrillo, el 37,5 % tiene amigos que lo usan y el 45,8 % no

había recibido información en el colegio. Los daños al corazón fueron los menos reconocidos (37,5 %).

2. **Estrategia (objetivo 2).** Se diseñó e implementó una estrategia participativa dinámicas grupales, charla informativa, semáforo de mitos y realidades y producción de mitos y realidades que los estudiantes valoraron de forma positiva. Los testimonios resultaron el mensaje más atractivo (68 %), lo que fundamenta la campaña final.
3. **Evaluación (objetivo 3).** Tras las actividades, el 100 % reporta haber recibido charlas (frente al 54,2 % inicial), el 92 % sabe que el vaper genera adicción y el 88 % que puede contener nicotina, aunque el empaque no lo indique. Sin embargo, la creencia de que es menos dañino bajó solo de 41,7 % a 36 % y el 76 % cree que los sabores lo hacen parecer menos peligroso.
4. **Influencia de los pares.** El 87,5 % señala a los amigos y compañeros como la principal influencia, pero el 92 % rechazaría una oferta de consumo y varios estudiantes sustentan su rechazo en razones de salud o de familia, lo que muestra que cuentan con factores de protección que conviene fortalecer.
5. **Alcance y limitaciones.** Los resultados son tendencias descriptivas: los grupos de las dos encuestas son de tamaño similar (24 y 25), pero no se puede confirmar que sean los mismos estudiantes, y algunas preguntas no son idénticas. Las actividades 3, 4 y 5 están en desarrollo y sus resultados completarán la evaluación.

Anexos

Anexo A: instrumentos y resultados de la encuesta diagnóstica

Tabla A1

Preguntas de la encuesta diagnóstica y resultados (n = 24)

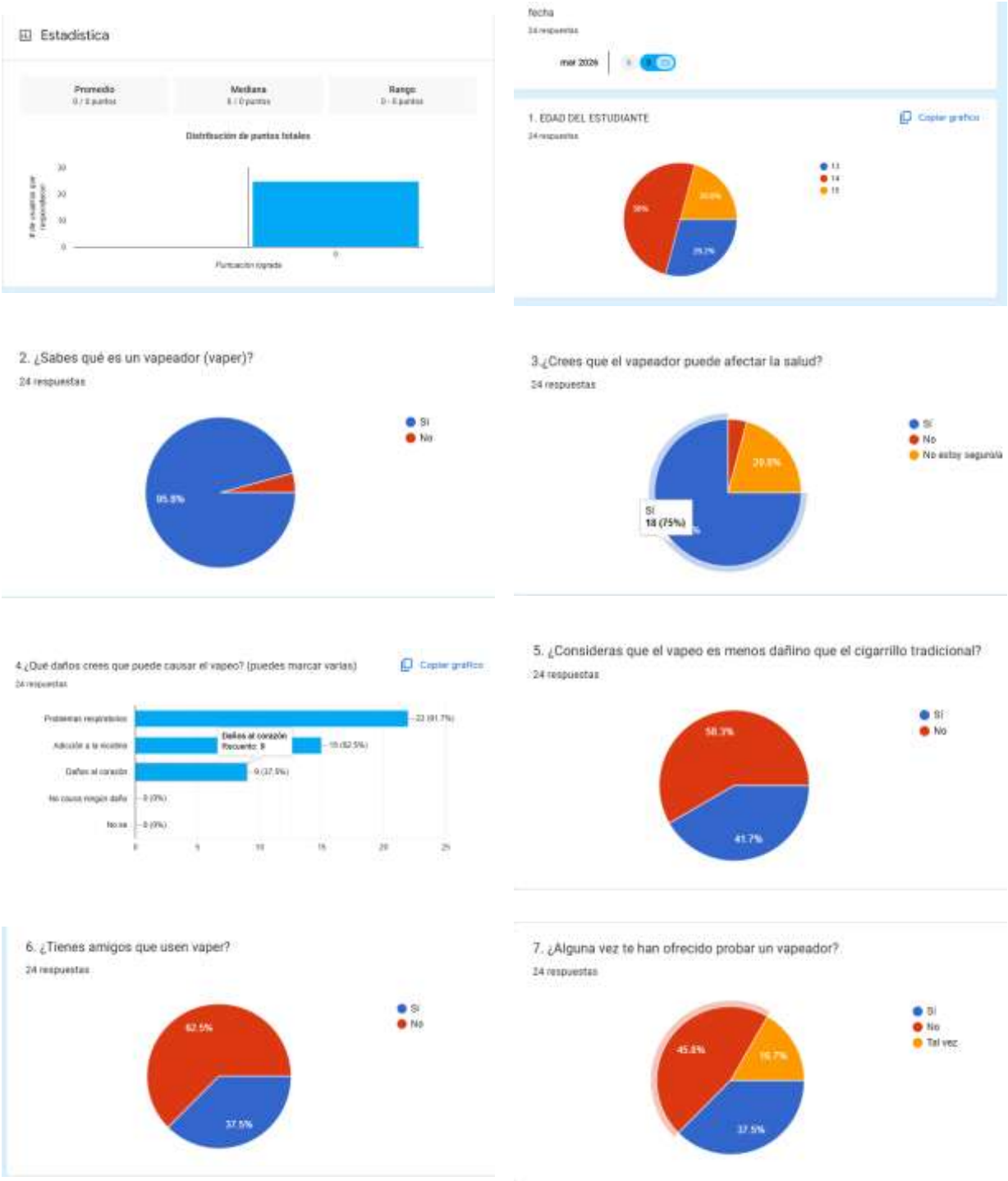
N.º	Pregunta	Resultados
1	Edad del estudiante	13 años: 7 (29,2 %) 14 años: 12 (50,0 %) 15 años: 5 (20,8 %)

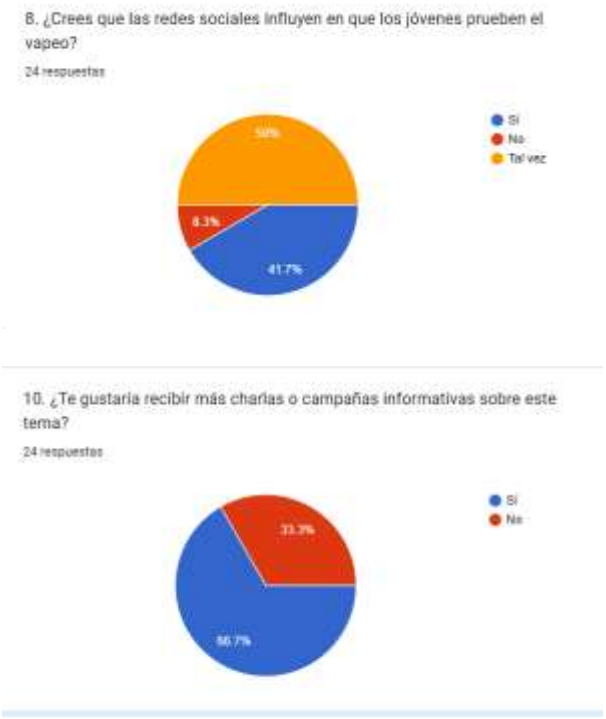
N.º	Pregunta	Resultados
2	¿Sabes qué es un vapeador (vaper)?	Sí: 23 (95,8 %) No: 1 (4,2 %)
3	¿Crees que el vapeador puede afectar la salud?	Sí: 18 (75,0 %) No: 1 (4,2 %) No estoy seguro/a: 5 (20,8 %)
4	¿Qué daños crees que puede causar el vapeo? (puedes marcar varias)	Problemas respiratorios: 22 (91,7 %) Adicción a la nicotina: 15 (62,5 %) Daños al corazón: 9 (37,5 %) No causa ningún daño: 0 No sé: 0
5	¿Consideras que el vapeo es menos dañino que el cigarrillo tradicional?	Sí: 10 (41,7 %) No: 14 (58,3 %)
6	¿Tienes amigos que usen vaper?	Sí: 9 (37,5 %) No: 15 (62,5 %)
7	¿Alguna vez te han ofrecido probar un vapeador?	Sí: 9 (37,5 %) No: 11 (45,8 %) Tal vez: 4 (16,7 %)
8	¿Crees que las redes sociales influyen en que los jóvenes prueben el vapeo?	Sí: 10 (41,7 %) No: 2 (8,3 %) Tal vez: 12 (50,0 %)
9	¿Has recibido información en el colegio sobre los riesgos del vapeo?	Sí: 13 (54,2 %) No: 11 (45,8 %)
10	¿Te gustaría recibir más charlas o campañas informativas sobre este tema?	Sí: 16 (66,7 %) No: 8 (33,3 %)
11	¿Qué crees que sería más efectivo para prevenir el uso del vapeador en jóvenes? (25 respuestas)	Testimonios reales: 8 (32 %) Charlas educativas: 6 (24 %) Campañas en redes sociales: 4 (16 %) Mayor control en la venta: 4 (16 %) Apoyo familiar: 3 (12 %)
12	¿Crees que deberían prohibirse los vapeadores para menores de edad?	Sí: 23 (95,8 %) No: 1 (4,2 %)

Anexo B: capturas de los resultados en Google forms

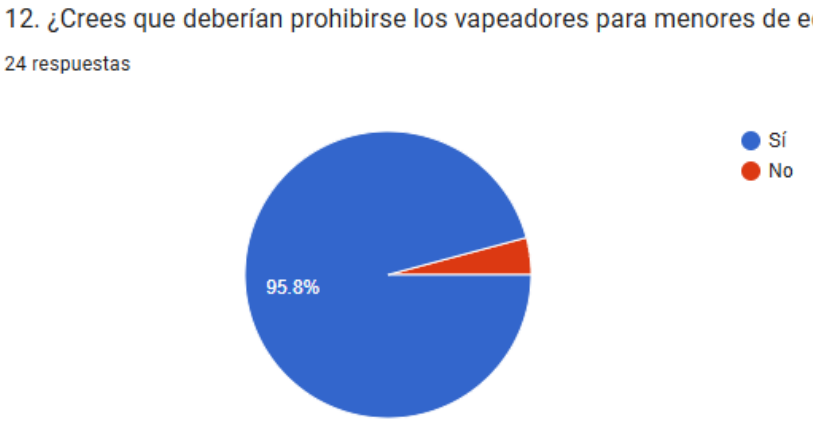
Figura A1

Resultados de la encuesta diagnóstica tal como los presenta Google Forms









Anexo C: instrumentos y resultados de la encuesta final

Tabla A2

Preguntas de la encuesta final y resultados (n = 25)

N.º	Pregunta	Resultados
1	¿Has escuchado charlas o talleres sobre los riesgos del vaper en el colegio?	Sí: 25 (100 %) No: 0 No recuerdo: 0

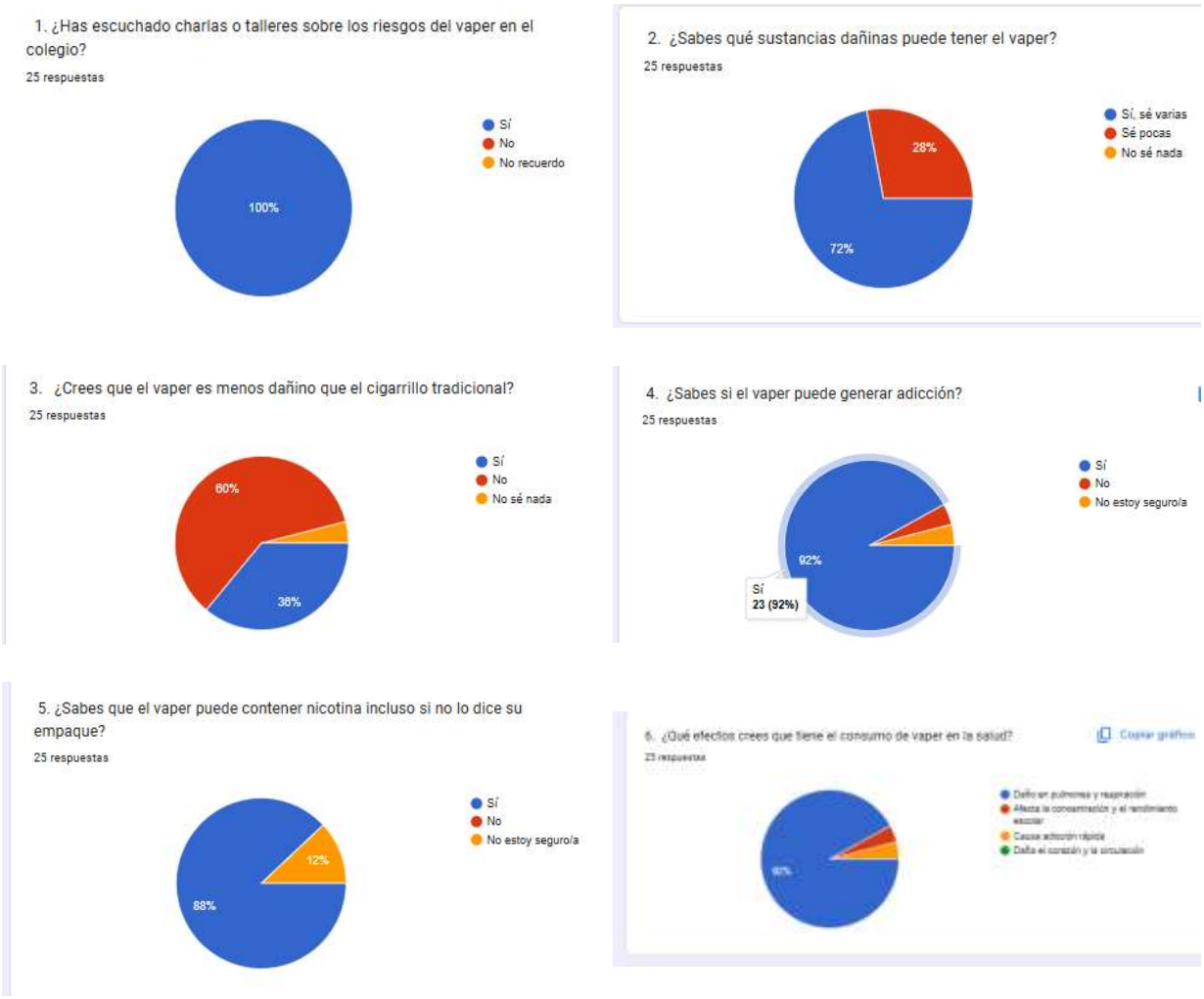
N.º	Pregunta	Resultados
2	¿Sabes qué sustancias dañinas puede tener el vaper?	Sí, sé varias: 18 (72 %) Sé pocas: 7 (28 %) No sé nada: 0
3	¿Crees que el vaper es menos dañino que el cigarrillo tradicional?	Sí: 9 (36 %) No: 15 (60 %) No sé nada: 1 (4 %)
4	¿Sabes si el vaper puede generar adicción?	Sí: 23 (92 %) No: 1 (4 %) No estoy seguro/a: 1 (4 %)
5	¿Sabes que el vaper puede contener nicotina incluso si no lo dice su empaque?	Sí: 22 (88 %) No: 0 No estoy seguro/a: 3 (12 %)
6	¿Qué efectos crees que tiene el consumo de vaper en la salud?	Daño en pulmones y respiración: 23 (92 %) Afecta la concentración y el rendimiento escolar: 1 (4 %) Causa adicción rápida: 1 (4 %) Daña el corazón y la circulación: 0
7	Si alguien te ofreciera vaper, ¿cómo reaccionarías? (abierta)	Ver Tabla 8 y Anexo E
8	¿Quién crees que influye más para que los jóvenes usen vaper? (n = 24)	Amigos y compañeros: 21 (87,5 %) Personas que ven en redes sociales: 3 (12,5 %) Publicidad: 0
9	¿Crees que los sabores hacen que el vaper parezca menos peligroso?	Sí, mucho: 11 (44 %) Un poco: 8 (32 %) No: 5 (20 %) No sé: 1 (4 %)
10	¿Crees que saber los daños reales ayuda a evitar el consumo?	Sí, totalmente: 13 (52 %) Ayuda un poco: 10 (40 %) No marca diferencia: 2 (8 %) No sé: 0
11	¿Qué tipo de información te llamaría más la atención?	Datos reales y cifras de salud: 6 (24 %) Testimonios de jóvenes que han dejado de consumir: 17 (68 %) Explicaciones breves y sencillas: 2 (8 %)

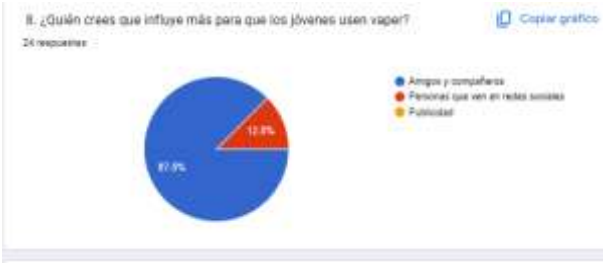
N.º	Pregunta	Resultados
12	Te gustó las charlas y actividades y pudiste entender mejor sobre las causas y consecuencias. Justifica tu respuesta. (abierta)	Ver Anexo E

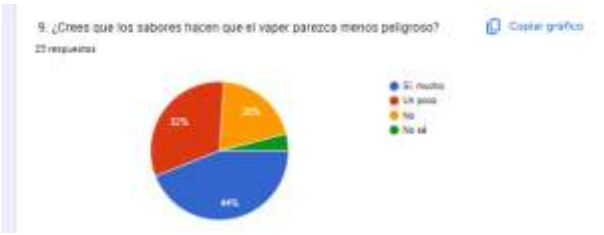
Anexo D: capturas de los resultados de la encuesta final

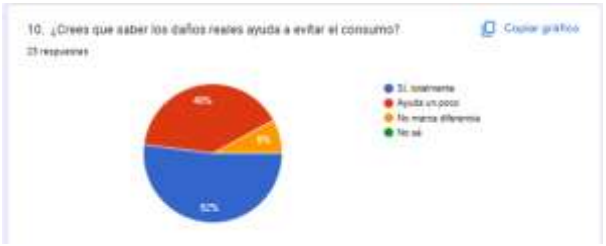
Figura D1

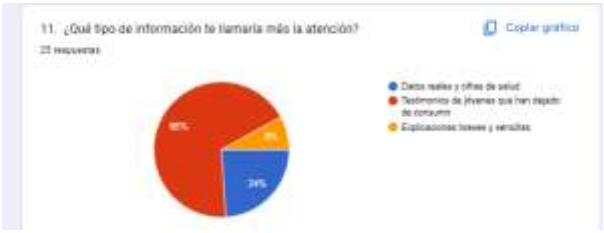
Resultados de la encuesta final tal como los presenta Google Forms (preguntas 1 a 6 y 8 a 11)











Anexo E: preguntas abiertas de la encuesta final

Tabla A3

Pregunta 7: si alguien te ofreciera vaper, ¿cómo reaccionarías? (n = 25)

N.º	Respuesta
1	No lo tomaría
2	Pues reaccionaría normal, pero le diría que no
3	No lo haría por cuidar mi salud
4	No consumo
5	No lo aceptaría
6	No gracias
7	No gracias, paso
8	Lo niego
9	Un poco sorprendida y también molesta
10	Que no, porque me da miedo
11	Me alejo
12	Le digo que no
13	No lo recibiría

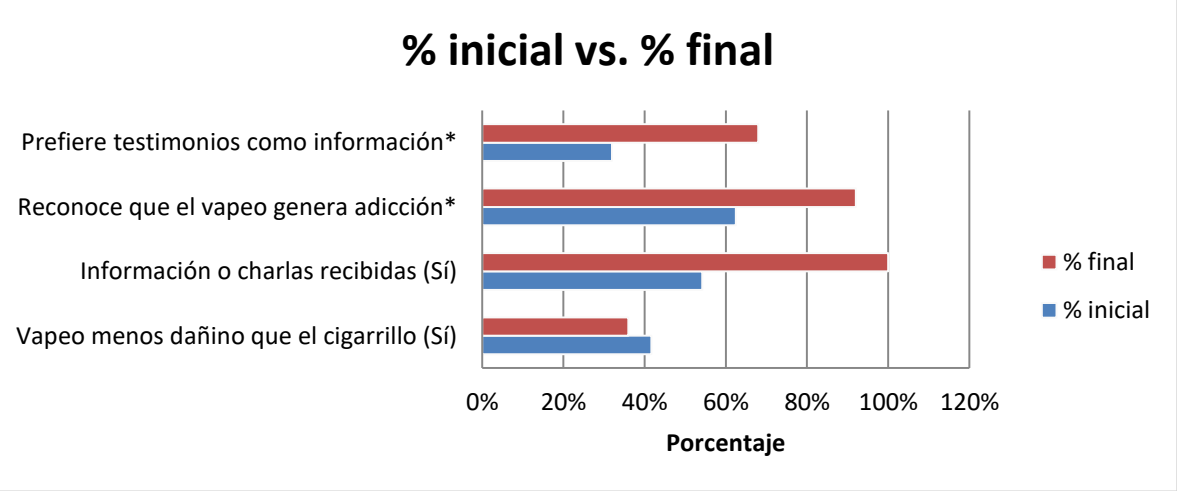
N.º	Respuesta
14	No quiero, gracias
15	Lo rechazo y me alejo de esa persona
16	No, porque no lo he probado y además no me interesa
17	Me daría curiosidad, pero igual no lo probaría
18	No, ya que las sustancias del vaper son muy dañinas a la salud y no quisiera decepcionar a mi familia
19	Lo pensaría
20	No, no lo haría porque no me gusta
21	No, gracias, no quiero dañar mi cuerpo
22	Le diría que no así me diera curiosidad
23	No lo aceptaría porque sé que es dañino
24	No consumo eso
25	Me negaría rotundamente

Tabla A4

Pregunta 12: justificación de si les gustaron las charlas y actividades (23 respuestas disponibles)

N.º	Respuesta
1	Sí
2	Me gustó
3	Me gustó porque fue muy lúdico y divertido
4	Sí me gustó porque nos enseñaron mucho y fue divertido
5	Sí, porque es dinámico
6	Sí, porque fueron dinámicas
7	Sí, aprendí muchas cosas de cómo cuidarme del vaper y no dejarme llevar cuando compañeros me quieran ofrecer
8	Sí, porque uno se da cuenta de las consecuencias que puede causar
9	Sí, ya que aprendí un poco sobre este tema y sus riesgos

N.º	Respuesta
10	Sí, me gustó
11	Sí me gustó, ya que aprendí más de los riesgos que puede traer
12	Sí, porque no sabía mucho de eso
13	Sí, porque ayuda a que los demás no desconozcan del tema
14	Sí, muy chéveres :)
15	Sí, porque me ayuda a comprender los riesgos
16	Sí me gustó porque nos enseñaron de algo muy importante
17	Me gustó porque nos ayudó a reforzar nuestro conocimiento
18	Sí me gustó porque fue muy entretenida
19	Sí me gustaron, aprendí más sobre qué hacer y qué no hacer sobre el vaper
20	Sí, ya que las charlas y actividades fueron muy interactivas y educativas
21	Sí, ya que fueron dinámicas y divertidas
22	Sí, mucho
23	Sí, ya que pude entender los daños del vaper mejor y aprender cosas que no sabía



Referencias

Álvarez Orozco, (2026).

Asociación Americana de Psiquiatría. (2022). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.ª ed., texto rev.

Becerra Benavides, G. S., Velásquez Leyton, J. S., & Benavides Riascos, L. D. (2022).

Benjoshep. (2026).

Congreso de Colombia. (2024, 9 de mayo). *Ley 2354 de 2024: Por medio de la cual se modifica el artículo 1. ° de la Ley 1335 de 2009 y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial n.° 52.751.

Eissenberg (2020).

Encuesta Nacional de Salud Escolar. (2023).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2023).

García, (2023).

González, (2023).

Hernández-Flores, (2025).

Instituto Nacional de Salud. (2024).

López & Ruiz. (2025).

Mendoza, (2025).

Ministerio de Educación Nacional. (2024). *Lineamientos para la promoción de entornos saludables y la prevención del consumo de sustancias en instituciones educativas*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024).

Monge Ríos. (2025).

Organización Mundial de la Salud. (2024).

Organización Panamericana de la Salud. (2023).

Organización Panamericana de la Salud. (2024).

Pérez, (2024).

Popova (2020).

Ramachandran, (2024).

Rodríguez, & Méndez, (202